

ACTIVIDAD DE SIMULACION CLINICA DE ALTA FIDELIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico en Enfermería	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Conflictos en la atención de salud
CURSO		N° ACTIVIDAD	2
ASIGNATURA	HES4111	DURACIÓN	80 minutos
FECHA	25/04/2025	N° DE ALUMNOS	12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
Aplicar técnicas de negociación para la resolución de conflictos en la atención de salud de acuerdo con su rol.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD		
- Diferencia los roles de los integrantes de un equipo de trabajo. - Asume su rol como TSEN dentro de un equipo. - Resolver constructivamente los conflictos que se presentan con su equipo de trabajo y los usuarios en la atención clínica. - Utiliza técnicas de negociación para la resolución de conflictos.		
4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	20 min	Descripción de la actividad, objetivos y aprendizajes esperados. Ambiente seguro y normas de la simulación
ESCENARIO	10 min	Descripción del escenario, tiempos y participantes /PS si corresponde
DEBRIEFING	40 min	Debriefing

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Corresponde al material o actividad obligatoria base para el desarrollo de la actividad simulada, por ejemplo: Lectura Guía del estudiante 2: Tipos de Conflicto.
Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: - Bienvenida a los estudiantes. - Dar a conocer los objetivos de la actividad. - Generar ambiente seguro. - Declaración del Principio básico.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	5. Realizar contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica 7. Descripción general de la actividad 8. Describir recursos generales para las actividades 9. Distribución de grupos 10. Rol del docente 11. Distribución del tiempo en la sesión.
5. ACTIVIDAD/ESCENARIO	
5.1 Caso clínico (desarrollo de la información que servirá como base para contextualizar al docente)	
Esta situación clínica se desarrolla en el servicio de oncología en donde un TENS que lleva un par de meses trabajando en el servicio queda a cargo de un interno de TENS que está en su primer día de internado. El TENS a cargo le pide al interno retirar y eliminar el medicamento citostático y la vía venosa de la paciente Cristina Barrios de 50 años quien padece de neuroblastoma, ya que es su último día de hospitalización.	
5.2 Información para el estudiante (Describir situación inicial de la simulación, entregando sólo la información relevante para el desarrollo de caso)	
Este escenario ocurre en el Servicio de oncología. Es el cuarto y último día de hospitalización de Cristina Barrios de 50 años quien padece de neuroblastoma. El TENS a cargo le pide al interno retirar y eliminar el medicamento citostático y la vía venosa de la paciente. El o la TENS a cargo lleva sólo un par de meses trabajando.	
5.3 Participantes y roles (describir los participantes que se necesitan para el desarrollo del escenario y una breve descripción de las instrucciones)	
Rol	Cantidad requerida
TENS servicio de Oncología	1
Interno(a) de TENS	1
Enfermera	1
Paciente	1
Instrucciones para los participantes	
TENS: Se encuentra muy cansado y atareado, aún no logra adaptarse al servicio de oncología, lleva recién dos meses trabajando, por lo que desconoce la mayoría de los protocolos. Acepta a el o la interna de TENS porque la jefa se lo pidió, pero considera que es un factor estresante adicional para usted. Le habla a él o la interna siempre con temor a equivocarse, con voz temblorosa, evita el contacto visual. Le indica retirar y eliminar el medicamento citostático y la vía venosa de la paciente Cristina Barrios de 70 años quien tiene neuroblastoma, pues según horario ya terminó de pasar y en la entrega de turno le dijeron que esa era la última dosis. Si él o la interna le comenta que la paciente tiene signos de flebitis usted sin mirar lo que pasa le responde que “hay que retirarlo no más porque ya es la última dosis y se va para la casa, sólo se le va a pasar”.	

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Si él o la interna no le comenta que la paciente tiene signos de flebitis usted sin mirar lo que pasa le pregunta “cómo se encuentra el sitio de inserción de la vía venosa”. Y si ahí le menciona los signos de flebitis usted le dice: “hay que retirarlo no más porque ya es la última dosis y se va para la casa, solo se le va a pasar”.

Cuando él o la interna de TENS le informa que el medicamento administrado no corresponde a la paciente usted le dice que “no puede ser posible yo mismo lo verifique e instale, así que elimine no más”.

Cuando él o la interna de TENS no le informa que el medicamento administrado no corresponde a la paciente usted le dice “Algún problema, que se demora tanto en eliminar el medicamento”.

Si el interno le refiere que lo va a reportar a la enfermera le dice que no puede hacerlo porque él esta a cargo de ud, no la enfermera, que lo evaluara mal si lo hace”.

Si hace lo que le pide y no le dice nada usted le dice que “En clínica, sólo estaba ese medicamento que lo más probable es que desde farmacia se equivocaron y que no pasará nada al paciente”.

Interno de TENS: Es su primer día de internado en el servicio de oncología. Usted debe realizar las acciones que TENS le indique.

Paciente: Usted se llama Cristina Barrios padece de neuroblastoma, se encuentra animada ya que es su último día de hospitalización, sólo está esperando a que termine de pasar la última dosis de fármaco que está pasando. Debe responder de manera cordial a las preguntas que le hagan y autoriza a que estudiante realice procedimiento. Ante el retiro de la VVP usted responde que le duele la zona que ha notado que tras la pasada del medicamento le apreció una coloración roja en la zona, le duele y siente calor local. Si le indican que se equivocaron en el medicamento pasado, usted se pone muy nerviosa y se descompensa, indicando que qué hará ahora, no se podrá ir a ver a su familia.

Enfermera (Confederado/Docente): Llega a la escena cuando está el conflicto desatado. Ingres a la escena y “pregunta qué sucede aquí”.

5.4 Instrucciones para los observadores

“Durante el desarrollo del escenario es importante que pongan especial atención en cómo es la relación entre TENS del servicio y el o la interna de TENS, cómo el o la interna de TENS realiza el procedimiento indicado, cuál es el conflicto principal y cómo se resuelve.

6. GUION PACIENTE SIMULADO (NO SE REQUIERE)

7. DESARROLLO DEL ESCENARIO SEGÚN CONDUCTAS

Conductas esperadas del participante (Nivel óptimo de la acción /comportamiento)	Respuesta si el estudiante REALIZA la conducta	Respuesta si el estudiante NO REALIZA la conducta
1. Estudiante se presenta con nombre y cargo.	Paciente: saluda y se mantiene tranquilo y con buena disposición a la atención	Paciente: se muestra desconfiado y le pregunta con tono molesto al estudiante ¿Quién es usted?

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

2. Estudiante menciona el procedimiento a realizar.	Paciente: autoriza el procedimiento. Al retiro de la vía venosa menciona signos de flebitis.	Paciente: desconfiado, le pregunta al TENS ¿qué me va a hacer este o esta joven? Y Al retiro de la vía venosa menciona signos de flebitis.
3. Estudiante realiza procedimiento de retiro de medicamento con EPP correspondiente.	TENS lo mira de reojo y no menciona nada.	TENS lo mira de reojo y si no se coloca los EPP, le menciona ¿qué está haciendo? Pare... ¡acuérdesse que debe colocarse EPP!
4. Estudiante revisa rotulo de medicamento antes de eliminarlo.	TENS lo mira de reojo y no menciona nada.	TENS lo mira fijamente y le indica que recuerde los correctos.
5. Estudiante reporta a TENS a cargo sobre error de medicación (nombre del medicamento administrado no coincide con la paciente), manteniendo la calma.	TENS de servicio: Cuando él o la interna de TENS le informa que el medicamento administrado no corresponde a la paciente usted le dice que “no puede ser posible yo mismo lo verifique e instale, así que elimine no más”.	TENS de servicio: Cuando él o la interna de TENS no le informa que el medicamento administrado no corresponde a la paciente usted le dice “Algún problema, que se demora tanto en eliminar el medicamento”.
5. Estudiante elimina vvp y reporta a TENS que paciente presenta signos de flebitis.	TENS de servicio: Si él o la interna le comenta que la paciente tiene signos de flebitis usted sin mirar lo que pasa le responde que “hay que retirarlo no más porque ya es la última dosis y se va para la casa, sólo se le va a pasar”.	TENS de servicio: Si él o la interna no le comenta que la paciente tiene signos de flebitis usted sin mirar lo que pasa le pregunta “cómo se encuentra el sitio de inserción de la vía venosa”. Y si ahí le menciona los signos de flebitis usted le dice: “hay que retirarlo no más porque ya es la última dosis y se va para la casa, solo se le va a pasar”.
6. Estudiante reporta a superior del servicio (enfermera) hallazgos encontrados posterior a conversar con TENS a cargo.	TENS de servicio: Si el interno le refiere que lo va a reportar a la enfermera le dice que “no puede hacerlo porque él está a cargo de usted, no la enfermera, que lo evaluara mal si lo hace”.	TENS de servicio: Si hace lo que le pide y no le dice nada usted le dice que “En clínica, sólo estaba ese medicamento que lo más probable es que desde farmacia se equivocaron y que no pasará nada al paciente”.
7. Estudiante mantiene la calma frente a la situación de conflicto.	Si logra mantener la calma TENS a cargo baja los niveles de estrés tratando de encontrar una solución.	TENS del servicio: se muestra autoritario, dándole la orden de no reportar lo sucedido.
8. Estudiante propone soluciones frente a los hallazgos.	TENS del servicio: Expone sus puntos de vista.	TENS del servicio: se muestra autoritario, dándole la orden de no reportar lo sucedido.
9. Estudiante logra llegar a un consenso con TENS a Cargo.	TENS del servicio: Conversa y logra llegar a un acuerdo con	TENS del servicio: se muestra autoritario, dándole la orden de

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	el estudiante.	no reportar lo sucedido.
10. Estudiante posee una actitud colaborativa en la resolución del conflicto.	TENS del Servicio: agradece su buena disposición.	TENS del servicio: se muestra autoritario, dándole la orden de no reportar lo sucedido.

8. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN DEBRIEFING

Estándar Diseño de simulación, criterio 9: Crear una sesión de Debriefing o Feedback y/o un ejercicio de reflexión guiada tras la experiencia basada en la simulación.

Estándar Proceso de Debriefing, Criterio 1: Planificado e incorporado a la experiencia basada en Simulación de forma adecuada para guiar a los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje o evaluación esperados.

HERRAMIENTA PEARLS Establecer el contexto	Recordar y reiterar los objetivos de la sesión, el contrato de confidencialidad y el principio básico a fin de promover la seguridad psicológica para esta etapa.
Reacciones	Consultar a los participantes sus reacciones al término de la simulación: ¿Cómo se siente después de haber atendido a doña Cristina? ¿Qué emociones predominan en usted al término de esta atención?
Descripción	Iniciar preguntando a los participantes de la simulación y luego ampliar la pregunta al resto de los participantes: ¿Podría describir cuáles fueron las acciones realizadas durante la atención? ¿Qué pasó en este escenario, quién podría describir lo ocurrido?, etc.
Análisis	¿Qué acciones consideran que se realizaron de manera correcta? ¿Por qué? Es importante profundizar en los marcos mentales de los estudiantes en esta etapa. ¿Qué acciones se podrían haber incorporado para lograr una atención integral? ¿Qué acciones pudieron hacerse mejor?, ¿Por qué?, etc.
Aplicación/Síntesis	¿La próxima vez que nos enfrentemos a una situación como esta, qué pasos o acciones se seguirán? ¿Qué estrategias de las conversadas, consideran que podrían contribuir a la mejora en su proceso de aprendizaje? ¿Cómo podrían incorporar a su práctica diaria lo aprendido hoy? ¿Cuál fue el principal aprendizaje de la sesión de hoy?

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLINICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA:	
Asignatura: HES 4111	N° Actividad Simulada: 2
Fecha de desarrollo: 25/04/2025	Fecha de revisión:

2. GESTIÓN DE SALA		
Características de sala a utilizar	Sala de hospitalización	Uso sala de Debriefing: Si <u>X</u> No <u> </u>
Condiciones de Sala (Grabación/Audio)		
NO APLICA	¿Cuál?	
Requiere equipo específico		
NO APLICA	¿Cual?	
Organización del ambiente		
Se utilizará sala de hospitalización en donde habrá un velador a la orilla de la cama, cama clínica en 180° en la parte central, con una porta sueros en el lado derecho, con fantoma de paciente sexo femenino con bata clínica con brazaletes de identificación, tapada con ropa de cama y con barandas arriba, en el antebrazo derecho tiene una VVP # 18, rotulada, permeable pasando medicamento citostático por bomba de infusión. En la zona de inserción de la Vía venosa, se debe simular una flebitis con enrojecimiento de la zona y edema. En la parte superior de la cama se debe dejar cenefa de gases simulada. Disponer en la sala de lavamanos, toallas secantes, elementos de protección personal, basureros de basura común, desechos peligrosos, tóxicos, especiales y material cortopunzante.		

3. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad/escenario (Breve resumen del caso, la progresión y los principales eventos o procedimientos)
Esta situación clínica se desarrolla en el servicio de oncología en donde un TENS que lleva un par de meses trabajando en el servicio queda a cargo de un interno de TENS que está en su primer día de internado. El TENS a cargo le pide al interno retirar y eliminar el medicamento citostático y la vía venosa de la paciente Cristina Barrios de 50 años quien padece de neuroblastoma, ya que es su último día de hospitalización. Interno se da cuenta que existe un error de medicación y que provocó una flebitis por lo que debe informar a TENS del servicio y a la enfermera.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Escenario a Preparar	Simulador /Preparación del simulador
<i>Sala de hospitalización Adulto, servicio de oncología.</i>	Simulador de sexo femenino, vestido con bata clínica, con brazalete de identificación (nombre Cristina Barrios Rut: 9.333.333-11) con vvp#18 en antebrazo derecho rotulada con los siguientes datos: número de la vv (vvp#18), fecha de instalación (24/05/25) e iniciales de la persona responsable de la instalación (LMR). En la zona de inserción de la Vía venosa, se debe simular una flebitis con enrojecimiento y edema en la zona. La vía venosa debe estar permeable conectada a un matraz de suero que simulará un medicamento citostático, el matraz debe estar rotulado con los siguientes datos: Nombre medicamento: Ciclofosfamida 500 mg EV Paciente: Cristina Barahona Sala: 503 Servicio Oncología Medicamento se pasará con bomba de infusión.

4. RECURSOS

Mobiliario nombre	Cantidad
Cama clínica	1
Velador	1
Mesa mayo	1
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Cenefa	1
Porta suero	1
Bomba de infusión	1
Basureros según REAS	
Caja cortopunzante	1
Bandeja de procedimientos	1
Insumos	Cantidad
Matraz de suero 500 ml rotulado según caso	1
Bajada de suero rotulada con fecha	1
Brazalete con datos según caso	1
Guantes de procedimientos de vinilo y nitrilo	1 caja de cada tamaño
Pecheras desechables	4
Cofias	4
Brazalete de identificación	1
Bolsa de desecho para medicamento citostático	2
Tórulas de algodón	1 Torulero
Cinta adhesiva	1
Dispensador de alcohol gel	1
Ropa y material de registro	Cantidad
Bata clínica	1

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Ficha clínica de paciente con receta de medicamento Nombre medicamento: Cisplastino 300 mg EV Paciente: Cristina Barrios Barrios Sala: 503 Servicio Oncología Horario 07- 15- 23	1
Hoja de enfermería con controles de signos vitales y registro de VVP según caso.	1

5. Referencias Bibliográficas (Vancouver)
1. Raffino, Equipo editorial, Etecé (13 de enero de 2025). Conflicto. Enciclopedia Concepto. Recuperado el 20 de abril de 2025 de https://concepto.de/conflicto/ .
2. Acerca de la gestión de conflictos [Internet]. Angloamerican.com. [citado el 26 de abril de 2025]. Disponible en: https://socialway.angloamerican.com/es-es/toolkit/impact-and-risk-prevention-and-management/conflict-management/introduction/about-conflict-management

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*